头晕和眩晕

知识类别：症状与就医指引
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/ear-nose-and-throat-disorders/symptoms-of-ear-disorders/dizziness-and-vertigo
获取日期：2026-10-17

以下为逐字转载的原文内容：

头晕和眩晕
病因 |
评估 |
治疗 |
老年人须知 |
关键点 |
多媒体 |
头晕是一个不精确的术语，人们常用来形容各种相关感觉，包括
头晕（感觉快要昏倒）
头晕（感觉快要昏倒）
头晕目眩
头晕目眩
平衡失调（感觉失去平衡或不稳定）
平衡失调（感觉失去平衡或不稳定）
模糊的精神恍惚或晕头转向的感觉
模糊的精神恍惚或晕头转向的感觉
感觉“头晕”或“摇晃”
感觉“头晕”或“摇晃”
眩晕（没有实际运动时出现运动错觉）
眩晕（没有实际运动时出现运动错觉）
眩晕是没有实际运动时出现运动错觉的头晕。人们通常会感觉自己、所处的环境或两者都在打转。这种感觉类似于童年时进行旋转游戏后突然停止旋转时产生的感觉，感觉周围都在旋转。有时，人们只是觉得像被拉向一侧。眩晕不是一个诊断。它是一种感觉的描述。
眩晕的人可能还有恶心、呕吐、平衡困难和/或行走困难的现象。有些人在眩晕发作时眼睛会有节奏地抽动（眼球震颤）。
不同的人经常以不同的方式使用术语“头晕”和“眩晕”，也许是因为这些感觉难以用言语来形容。同时，人们也会在不同的时间以不同方式描述自己的感受。例如，某次感觉就像头重脚轻，而下次就像眩晕。
无论怎样描述，这些感觉可能会令人不安，甚至失去劳动能力，尤其是当伴有恶心，呕吐时。症状会导致从事严格或危险任务（例如开车、飞行或操作重型机械）的人出现特定问题。
在美国为期一年的健康调查中，11% 的成年人报告感到头晕。在另一项研究中，10 年间，头晕占急诊科就诊人数的 2.5%。它可能发生在任何年龄，但老年人更常见。
头晕可能是暂时的或慢性的。头晕如果持续一个多月会被视为慢性头晕。慢性眩晕在老年人中更为常见。

对于仅在站起时发生的头晕，见 站起时头晕或头重脚轻 。
您知道吗……
您知道吗……
大多数时间，即使失去劳动能力，头晕也不是源自严重病症。 在老年人中，头晕往往不具有单一的明显原因。
大多数时间，即使失去劳动能力，头晕也不是源自严重病症。
大多数时间，即使失去劳动能力，头晕也不是源自严重病症。
在老年人中，头晕往往不具有单一的明显原因。
在老年人中，头晕往往不具有单一的明显原因。
头晕和眩晕的病因
眩晕通常由维持平衡的耳部和脑部结构的疾病导致：
内耳
内耳
脑干和小脑
脑干和小脑
连接内耳与脑干和小脑的神经束
连接内耳与脑干和小脑的神经束
内耳包含了使身体感知位置和运动的结构（半规管、球囊和椭圆囊）。来自这些结构的信息通过前庭蜗神经（第八颅神经，这也涉及听觉）发送到脑部。这个信息在脑干（调整姿势）和小脑（协调动作）中进行处理，以提供平衡感。任何这些结构的病症都可引起眩晕。内耳疾病有时还会造成听力损失和/或耳内铃声（ 耳鸣 ）。（见图 耳部内视图 。）
耳部内视图
耳部内视图
此外，影响大脑一般功能的任何疾病（例如， 低血糖 、 低血压 、严重 贫血 或许多药物）都能让人感觉头晕。虽然症状可能令人不安，甚至致残，但只有较少比例病例源自严重疾病。
常见原因
虽然有一些重叠，但头晕原因可大致分为眩晕性原因和无眩晕性原因。
眩晕 性头晕的最常见原因 包括：
良性阵发性位置性眩晕
良性阵发性位置性眩晕
美尼尔氏病
美尼尔氏病
前庭神经元炎
前庭神经元炎
迷路炎
迷路炎
前庭性偏头痛
前庭性偏头痛
前庭性偏头痛越来越被视为伴有眩晕的头晕的常见原因。这种类型的 偏头痛 最常发生于有偏头痛史或家族史的人群。此类患者经常出现伴有头晕或眩晕的头痛。有些人还有其它的类似于偏头痛的症状，例如看见闪烁的灯、有临时的盲点，或者对光线和声音非常敏感。患者还可能出现听力损失，但它不是一种常见的症状。
无 眩晕性头晕的最常见原因 包括：
前庭性偏头痛

前庭性偏头痛
药物，尤其是治疗高血压的药物
药物，尤其是治疗高血压的药物
多因素病因
多因素病因
某些类型的药物可引起头晕。有些药物对耳朵和/或平衡器官神经具有直接的毒性（ 耳毒性药物 ）。这些药物会导致头晕和不能集中在可视目标上（视振荡）。其他药物，例如镇静药，会影响整个脑部。在老年人中，头晕往往由多种因素造成，通常是药物的副作用加上与年龄有关的感觉功能下降相结合。
当脑部的氧气和葡萄糖不足（ 低血糖 ）时，可能会出现非眩晕性头晕，这可能与非神经系统疾病（包括心脏和肺部疾病或严重贫血）有关。
恐慌症 、 气短 、 焦虑 或 抑郁 患者比没有这些疾病的患者更常出现头晕。
很多时候，在没有发现特别原因的情况下，症状无需治疗便消失了。
不常见原因
头晕较少见的原因包括以下：
前庭耳蜗神经肿瘤（ 前庭神经鞘瘤 ）
前庭耳蜗神经肿瘤（ 前庭神经鞘瘤 ）
其他脑肿瘤
其他脑肿瘤
卒中 或影响脑干的短暂性脑缺血发作（ TIA ）
卒中 或影响脑干的短暂性脑缺血发作（ TIA ）
耳膜、内耳或颅底损伤
耳膜、内耳或颅底损伤
多发性硬化症
多发性硬化症
妊娠
妊娠
头晕和眩晕的评估
下面的信息可以帮助头晕的患者决定是否需要医生评估，并帮助他们了解在评估期间会发生什么。
警示体征
在头晕患者中，某些症状和特征需要引起关注。它们包括
新发或严重头痛
新发或严重头痛
颈痛
颈痛
行走困难
行走困难
意识丧失（晕倒）
意识丧失（晕倒）
其它神经系统症状（如听觉、视觉、说话或吞咽障碍、或难以移动手臂或腿）
其它神经系统症状（如听觉、视觉、说话或吞咽障碍、或难以移动手臂或腿）
何时就医
具有警示体征的人、症状严重或已持续一个小时以上的人、以及出现呕吐的人应立即前往医院。其他人也应尽快看医生。发作一次、短暂（不到1分钟）、症状轻微并且没有其它症状的患者可以选择等待

，看看是否还会发作。
医生会怎么做
对于头晕的患者，医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，经常可以提示出现头晕的病因和应该对患者所做的检查（见 头晕的一些原因和特征）。
除了警示体征外，医生会询问的其他重要特征，包括症状的严重程度（患者是否摔倒或误工）、出现呕吐和/或耳鸣、症状是否出现后又消失或一直持续，以及症状的潜在触发因素（例如改变头部位置或服用一种新药）。
在体格检查中， 耳、眼和神经系统检查特别重要。医生会进行听力测试，并检查耳道和耳膜是否异常。检查眼睛是否有异常移动，例如眼球震颤。
听力损失 或 耳内铃声 （ 耳鸣 ）提示患者可能有内耳疾病。
眼球震颤 表明存在影响内耳或脑干内各种神经连接的疾病。眼球震颤是指眼球反复、快速地向某一个方向运动，然后又慢慢地返回到它们原来的位置。如果患者自己未自发出现眼球震颤，医生会刻意引发此现象，因为眼睛移动方向和眼球震颤持续时间可以帮助医生诊断眩晕的原因。为了触发眼球震颤，医生会首先让患者背部着床躺下，然后轻轻地将患者从一侧滚动到另一侧，同时观察他们的眼睛。专科医生有时会让患者戴上厚厚的单向放大镜（称为 Frenzel 镜片）。医生可以很容易地透过镜片看到患者放大的眼睛，但患者只能看到模糊的影像，不能注视任何东西（注视时会更难触发眼球震颤）。为了引起眼球震颤，可以在每只眼睛周围放置电极（粘在皮肤上的传感器）来记录眼睛移动（眼震电图），或用连接到 Frenzel 镜片的摄像机记录眼睛的移动（视频眼震电图）。如果在来回滚动的过程中没有出现眼球震颤，医生会尝试其它手法。这些其它手法包括将冰冷的水注入耳道（热量测试），然后迅速改变患者的头部位置（ Dix-Hallpike 试验 ）。
医生还会进行完整的神经系统检查，尤其注意行走、平衡和协调性测试。
头晕的一些原因和特征
头晕的一些原因和特征
病因
病因
临床特征*
临床特征*
诊断方法
诊断方法
常见原因
常见原因
良性阵发性位置性眩晕 (BPPV)
良性阵发性位置性眩晕 (BPPV)
向着特定方向移动头部，特别是当躺下时，引发严重、短暂（ 持续不到 1 分钟）的旋转感 有时恶心和呕吐 听力和神经功能正常
向着特定方向移动头部，特别是当躺下时，引发严重、短暂（ 持续不到 1 分钟）的旋转感
有时恶心和呕吐
听力和神经功能正常
仅进行医生检查，通常包括 Dix-Hallpike 试验
仅进行医生检查，通常包括 Dix-Hallpike 试验
美尼尔氏病
美尼尔氏病
多次彼此独立的眩晕发作，每次持续 20 分钟到 2 小时，伴有耳鸣、听力减退和耳内胀满感/压力感

，通常仅累及一只耳
多次彼此独立的眩晕发作，每次持续 20 分钟到 2 小时，伴有耳鸣、听力减退和耳内胀满感/压力感
，通常仅累及一只耳
听力图 钆增强型 MRI，以排除其他原因
听力图
钆增强型 MRI，以排除其他原因
前庭神经元炎 （可能由病毒引起）
前庭神经元炎 （可能由病毒引起）
突然的剧烈眩晕，无听力损失及其它发现 严重眩晕可能会持续数天，症状逐渐减轻，并可能发展成位置性眩晕
突然的剧烈眩晕，无听力损失及其它发现
严重眩晕可能会持续数天，症状逐渐减轻，并可能发展成位置性眩晕
有时，仅进行医生检查 有时进行钆增强型MRI
有时，仅进行医生检查
有时进行钆增强型MRI
迷路炎 （病毒或细菌引起）
迷路炎 （病毒或细菌引起）
伴严重眩晕的突发性听力损失，常伴随耳鸣
伴严重眩晕的突发性听力损失，常伴随耳鸣
听力图 颞骨 CT扫描（如果医生怀疑有细菌感染） 针对听力损失和耳鸣患者进行钆增强型MRI以排除肿瘤
听力图
颞骨 CT扫描（如果医生怀疑有细菌感染）
针对听力损失和耳鸣患者进行钆增强型MRI以排除肿瘤
影响内耳的药物 （特别是氨基糖苷类抗生素、氯喹、速尿和奎宁）
影响内耳的药物 （特别是氨基糖苷类抗生素、氯喹、速尿和奎宁）
通常双耳听力损失 可能最近开始使用的致病药物
通常双耳听力损失
可能最近开始使用的致病药物
听力图 有时进行眼震电图描及转椅测试来看有无提示内耳损伤的异常眼球运动
听力图
有时进行眼震电图描及转椅测试来看有无提示内耳损伤的异常眼球运动
影响整个脑部的药物（特别是治疗焦虑、抑郁和癫痫发作的药物，以及普通镇静药）
影响整个脑部的药物（特别是治疗焦虑、抑郁和癫痫发作的药物，以及普通镇静药）
与运动和体位无关的症状 没有听力损失及其它症状 可能最近开始使用的致病药物
与运动和体位无关的症状
没有听力损失及其它症状
可能最近开始使用的致病药物
有时仅需医生进行体格检查 有时，测量某些致病药物的血液浓度 有时，停止用药，以观察症状是否停止
有时仅需医生进行体格检查
有时，测量某些致病药物的血液浓度
有时，停止用药，以观察症状是否停止
慢性 晕动症 （常见）

慢性 晕动症 （常见）
急性晕动症后持续症状
急性晕动症后持续症状
仅进行医生检查
仅进行医生检查
偏头痛
偏头痛
多次单独发作的眩晕或慢性头晕发作，有时伴有恶心 头痛或其他偏头痛症状，如视觉或其他先兆（头痛之前出现的感觉改变，例如灯光闪烁）以及头晕发作时对光和/或噪声敏感 偏头痛的个人或家族史
多次单独发作的眩晕或慢性头晕发作，有时伴有恶心
头痛或其他偏头痛症状，如视觉或其他先兆（头痛之前出现的感觉改变，例如灯光闪烁）以及头晕发作时对光和/或噪声敏感
偏头痛的个人或家族史
有时，仅进行医生检查 有时进行 MRI 排除其他原因 有时，试用药物来治疗和预防偏头痛
有时，仅进行医生检查
有时进行 MRI 排除其他原因
有时，试用药物来治疗和预防偏头痛
不常见原因，通常 伴有 耳部症状（听力损失和/或耳鸣）
不常见原因，通常 伴有 耳部症状（听力损失和/或耳鸣）
耳带状疱疹
耳带状疱疹
面部无力和味觉丧失常与同侧听力丧失同时出现 可能出现眩晕 在耳的外侧（耳廓）有水泡（小泡），且耳道内也有
面部无力和味觉丧失常与同侧听力丧失同时出现
可能出现眩晕
在耳的外侧（耳廓）有水泡（小泡），且耳道内也有
仅进行医生检查
仅进行医生检查
中耳感染（ 急性 或 慢性 ）
中耳感染（ 急性 或 慢性 ）
耳痛，有时耳溢液 检查期间耳膜外观异常
耳痛，有时耳溢液
检查期间耳膜外观异常
听力图 有时进行 CT扫描（针对慢性感染患者）
听力图
有时进行 CT扫描（针对慢性感染患者）
外伤（如鼓膜破裂、颅骨骨折或脑震荡）
外伤（如鼓膜破裂、颅骨骨折或脑震荡）
近期明显外伤 根据损伤位置和程度的其它发现
近期明显外伤
根据损伤位置和程度的其它发现
有时进行听力图检查 有时进行 CT 扫描
有时进行听力图检查
有时进行 CT 扫描

前庭神经鞘瘤
前庭神经鞘瘤
缓慢的进行性单耳听力损失和耳鸣 罕见情况下有脸部麻木和/或无力
缓慢的进行性单耳听力损失和耳鸣
罕见情况下有脸部麻木和/或无力
听力图 钆增强型MRI
听力图
钆增强型MRI
半规管周围的骨缺陷（上半规管裂隙）
半规管周围的骨缺陷（上半规管裂隙）
声音或高压引起的头晕（如打喷嚏时）、低音调听力损失
声音或高压引起的头晕（如打喷嚏时）、低音调听力损失
鼓室导抗听力图 CT 扫描 前庭测试
鼓室导抗听力图
CT 扫描
前庭测试
不常见原因，通常 没有 耳部症状
不常见原因，通常 没有 耳部症状
贫血
贫血
苍白或无力或疲劳
苍白或无力或疲劳
血液化验
血液化验
脑干中风
脑干中风
突然发病，症状持续
突然发病，症状持续
立即进行钆增强型MRI
立即进行钆增强型MRI
小脑出血
小脑出血
突然发病，伴有持续的症状 行走和协调性测试困难 经常头痛 症状迅速恶化
突然发病，伴有持续的症状
行走和协调性测试困难
经常头痛
症状迅速恶化
立即进行钆增强型 MRI（或 CT 扫描）
立即进行钆增强型 MRI（或 CT 扫描）
多发性硬化症
多发性硬化症
神经系统症状的多次单独发作，例如影响身体不同部位的不同发作伴无力或麻木
神经系统症状的多次单独发作，例如影响身体不同部位的不同发作伴无力或麻木
钆增强型脑部和脊椎 MRI

钆增强型脑部和脊椎 MRI
低血糖 （通常由糖尿病治疗药引起）
低血糖 （通常由糖尿病治疗药引起）
最近增加了剂量 有时出汗
最近增加了剂量
有时出汗
指尖葡萄糖测试（如果可能，在症状出现期间进行检测）
指尖葡萄糖测试（如果可能，在症状出现期间进行检测）
低血压 （例如由心脏疾病、降压药、失血或脱水引起）
低血压 （例如由心脏疾病、降压药、失血或脱水引起）
起身时症状出现，但头部移动或平躺时无症状 病因症状通常明显（如严重失血或腹泻）
起身时症状出现，但头部移动或平躺时无症状
病因症状通常明显（如严重失血或腹泻）
针对疑似原因进行测试
针对疑似原因进行测试
持续性姿势 - 知觉性头晕 (PPPD)
持续性姿势 - 知觉性头晕 (PPPD)
慢性非旋转性头晕（一种内在的摆动感）持续超过 3 个月，大多数日子里都会出现
慢性非旋转性头晕（一种内在的摆动感）持续超过 3 个月，大多数日子里都会出现
仅进行医生检查
仅进行医生检查
妊娠 （通常患者自己不知道）
妊娠 （通常患者自己不知道）
有时月经期延迟和/或孕吐 无耳部症状
有时月经期延迟和/或孕吐
无耳部症状
妊娠试验
妊娠试验
精神病（如惊恐发作、换气过度综合征、焦虑、抑郁）
精神病（如惊恐发作、换气过度综合征、焦虑、抑郁）
慢性、短暂、复发性症状 与运动或体位无关，但可能发生在应激或不适时 耳朵和神经系统检查正常
慢性、短暂、复发性症状
与运动或体位无关，但可能发生在应激或不适时
耳朵和神经系统检查正常
仅进行医生检查
仅进行医生检查
梅毒
梅毒
慢性症状，伴有时不时的双耳听力损失和眩晕发作
慢性症状，伴有时不时的双耳听力损失和眩晕发作
听力图 梅毒血液检测
听力图
梅毒血液检测
甲状腺疾病

甲状腺疾病
体重变化 不能耐热或耐寒
体重变化
不能耐热或耐寒
血液检测甲状腺功能
血液检测甲状腺功能
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
大多数病人应该进行全面的听力测试（听力图）。
大多数病人应该进行全面的听力测试（听力图）。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
大多数病人应该进行全面的听力测试（听力图）。
大多数病人应该进行全面的听力测试（听力图）。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
在头晕和眩晕的患者中需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在危险信号。
对于突然头晕发作仍在继续的患者，医生通常采用指尖血氧仪，取指尖血测量血糖含量。一些女性会接受妊娠测试。
具有警示体征的人需要进行钆增强型磁共振成像（MRI）检查，没有警示体征但症状存在很久的人也应接受该检查。
若干测试可用于评价平衡和步态，例如 Romberg 测试 。另一项平衡测试需要患者沿着直线行走（一只脚在另一只脚后面）。如果医生检查显示可能存在听力损失，患者通常需要转诊接受规范的听力测试（ 听力图 ）。
有时会进行全面的前庭检查。该测试包括视频眼震电图描记（对异常眼球运动的电脑记录和分析）、转椅测试（看坐在转椅上时有无异常眼球运动）和前庭诱发肌源性电位测试。这些测试通常由耳部专科医生（耳鼻喉科）完成。
可能会进行心电图（ECG）、针对心律异常的动态心电图、超声心动图、运动压力测试来评估心脏功能。对于 仅在站起时出现的头晕 ，可能需要特定测试。
头晕和眩晕的治疗
应尽可能治疗头晕的病因。治疗包括停止或减少任何致病药物的剂量，或转为使用其他药物。
可以用药物治疗恶心和呕吐，例如美克洛嗪或异丙嗪。
内耳疾病（例如 美尼尔氏病 、 迷路炎 、偏头痛相关眩晕、或 前庭神经元炎 ）导致的眩晕通常可以使用抗组胺药物（如美克洛嗪）或苯二氮卓类药物（如地西泮或劳拉西泮）缓解。
良性阵发性位置性眩晕 患者中的眩晕可由经验丰富的医生或物理治疗师通过 Epley 手法 （一种头部的空翻样动作）治疗。有时，患者会学习如何在家中使用这一手法，以在复发时帮助缓解症状。
美尼尔氏病 最好由接受过此慢性疾病管理的耳鼻喉科医生处理，但初始管理包括低盐饮食和利尿剂（水丸），但这可能并非对所有患此病的患者都有效。
在同时发生偏头痛的眩晕患者中，治疗偏头痛。
前庭物理治疗（平衡物理治疗）是慢性头晕患者的主要治疗手段。无论慢性头晕或眩晕的病因是什么

，大多数人都能通过前庭物理治疗改善病情。治疗师也可以推荐如下策略：
避免可能引发头晕的动作，例如抬头或弯腰
避免可能引发头晕的动作，例如抬头或弯腰
将物品存放在易于接触的地方
将物品存放在易于接触的地方
坐下后或躺下后缓慢起身
坐下后或躺下后缓慢起身
站立前紧握双手并弯曲双脚
站立前紧握双手并弯曲双脚
学习结合眼睛、头部和身体运动的练习，有助于防止头晕
学习结合眼睛、头部和身体运动的练习，有助于防止头晕
进行 物理治疗 和锻炼，增强肌肉和尽可能长时间保持独立的步态
进行 物理治疗 和锻炼，增强肌肉和尽可能长时间保持独立的步态
接受前庭康复治疗（一种专门的物理治疗形式）
接受前庭康复治疗（一种专门的物理治疗形式）
老年人须知：头晕和眩晕
随着人们年龄的增长，很多因素都会导致头晕和眩晕更加常见。参与平衡的器官，特别是内耳的结构，功能会下降。视力问题也可以导致向大脑提供不一致的信息，从而改变平衡感。控制血压的身体机制响应更慢（例如，站起来）。老年人还更有可能服用可以导致头晕的药物。最后，大脑感知其空间位置（本体感受）和感知足部触觉的能力通常会随着年龄的增长而降低。
虽然头晕和眩晕在任何年龄都会令人不快，但它们会给老年人带来特殊的问题。体质虚弱的人、年纪较大的人，在头晕时跌倒和受到严重伤害的风险要高得多。即使他们没有跌倒，他们对跌倒的恐惧往往显著影响他们从事日常活动的能力。
有助于缓解眩晕的药物能使人感到昏昏欲睡。这种作用在老年人中更常见，有时会更加严重。
患有头晕或眩晕的老年人可以从一般的 物理治疗 和锻炼中受益，以加强他们的肌肉，帮助他们保持自己的独立性，该效果甚至比年轻人还要好。物理治疗师也可以提供针对老年人或残疾人的重要安全信息，帮助防止跌倒。
关键点
头晕和眩晕往往是由影响内耳或参与平衡的脑部的疾病引起的，或因为使用某些处方药而引起的。
头晕和眩晕往往是由影响内耳或参与平衡的脑部的疾病引起的，或因为使用某些处方药而引起的。
症状可能包括虚脱、平衡失调、眩晕、难以描述的头重脚轻或晕头转向感，或合并出现。
症状可能包括虚脱、平衡失调、眩晕、难以描述的头重脚轻或晕头转向感，或合并出现。
剧烈头痛和脑功能异常的任何迹象（如行走、说话、视物、言语或吞咽困难）都是警示体征，但即使不明确的症状也可能是由严重的疾病引起的。
剧烈头痛和脑功能异常的任何迹象（如行走、说话、视物、言语或吞咽困难）都是警示体征，但即使不明确的症状也可能是由严重的疾病引起的。
出现警示体征的人应立即去看医生，他们往往需要进行检查。
出现警示体征的人应立即去看医生，他们往往需要进行检查。
美克洛嗪或地西泮等药物通常有助于缓解眩晕，丙氯拉嗪可以帮助减轻恶心。
美克洛嗪或地西泮等药物通常有助于缓解眩晕，丙氯拉嗪可以帮助减轻恶心。